

УДК: 618.14+/.146-006.6-08-059

М.Р.Кайрбаев, Ж.К. Чингисова, Е.К. Кукубасов, Р.Ш. Шалбаева, Ж. Досаханов
Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы, Республика Казахстан

Роль неоадьювантной полихимиотерапии в лечении онкогинекологического рака

Аннотация. Современная лекарственная терапия рака является перспективным методом лечения злокачественных опухолей, в том числе онкогинекологического рака.

Материал и методы. Клинический материал составил 50 больных РШМ и 73 пациенток РТМ.

При исследовании выделены по 2 группы: в первую группу (основную) включено 20 пациенток РШМ, которым проведен метрономный курс полихимиотерапии и 35 больных РТМ, которым проведены неоадьювантные курсы полихимиотерапии. Всем больным проведено оперативное вмешательство.

Полученные результаты с применением полихимиотерапии в неоадьювантном режиме при раке шейки и тела матки свидетельствовали об эффективности лечения этих больных.

Применение метрономной полихимиотерапии показало значительную эффективность у ранее не леченых больных РШМ - 95% (частичная регрессия+стабилизация процесса). Восстановление функции мочевого пузыря, после нервосберегающих операций происходит в среднем на 11±4,7 суток раньше, что существенно сказывается на качестве жизни пациенток с РШМ и имеет положительный экономический эффект.

Метод комплексной терапии с применением неоадьювантной полихимиотерапии по предложенной схеме у больных раком тела матки позволил получить: терапевтический эффект в 74,3% случаев; непосредственный эффект был выше у больных II стадией (степень регрессии более 75% установлена в 71,4±5,9% случаев); оценка лекарственного патоморфоза установила II-III степени повреждения в 88,5% случаев.

Проблема онкогинекологического рака продолжает оставаться актуальным вопросом научных исследований в онкологии. Среди злокачественной патологии репродуктивной системы у женщин рак тела матки выходит на 2 место, а рак шейки матки на 3 место в экономически развитых странах и России (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2010) [1].

Исследования по вопросам применения химиотерапии при лечении больных раком тела матки не теряют своей актуальности. Проведение неоадьювантной полихимиотерапии при раке тела матки оказалось эффективным при наличии ряда неблагоприятных прогностических факторов. Так при умеренно- и низкодифференцированных опухолях эндометрия применение двух курсов неоадьювантной внутриартериальной полихимиотерапии позволяет добиться 80%-ой регрессии первичных опухолей у 75%

больных (Байназарова А.А., 2001) [2].

Рак шейки матки относится к числу тех опухолей, у которых возможности дополнительного использования химиотерапевтических препаратов весьма ограничены, в силу известной незначительной их эффективности при этой патологии.

Определенные достижения лекарственной терапии по разработке принципов и режимов комбинированной химиотерапии с цикловым последовательным введением противоопухолевых препаратов привели к новой волне использования лекарственных средств, в том числе и при лечении рака шейки матки.

Современная лекарственная терапия рака является перспективным методом лечения злокачественных опухолей. Актуальным является расширение ее возможностей за счет совершенствования стандартных методик и создания новых схем по механизму действия противоопухолевых агентов (Резцова В.В., 2007; Fleming G.A., 2008 [3, 4]. Правильное ее использование с другими традиционными методами (хирургическим и лучевым) лечения создает реальную возможность помощи онкологическим больным (Акимов А.А., 2001) [5].

Материал и методы

Клинический материал исследования составил 50 больных раком шейки матки. Распределение больных в группах были сопоставимы по основным клиническим признакам. 20 больным (I группа, пациентки с опухолью более 4,0 см.) раком шейки матки проведено комбинированное лечение, включающее полихимиотерапию в метрономном режиме и оперативное лечение. 30 больных (II группа, пациентки с опухолью не более 4,0 см.) получили лечение в объеме хирургического вмешательства. Распределение больных по стадиям выглядело следующим образом: Ib1 стадия установлена у 16 (32,0±4,9%) больных, Ib2 стадия выявлена у 13 (26,0±5,5%), IIa1 стадия диагностирована у 14 (28,0±5,7%) женщин, процент больных, имевших IIb2 стадию, составил 14,0±5,6% - 7 пациенток.

Исследования по раку тела матки основаны на 73 больных. Распределение пациентов в сравниваемых группах (1 и 2) были сопоставимы по основным клиническим признакам. 35 больным раком эндометрия проведено комплексное лечение, включающее неоадьювантную химиотерапию, оперативное лечение и послеоперационный курс лучевой терапии. Распределение по стадиям было следующим: I стадия установлена у 44 (60,3±4,7%) больных. Из них в основной (первой) группе пациенток с I стадией было 21 (60,0±5,7%) человек, в сравниваемой (второй) 23 (60,5±5,7%). II стадия процесса выявлена у 20,5±4,0% больных; в основной группе процент больных, имевших II стадию, составил 20,0±5,6%, в контрольной - 21,1±4,7%. Пациенток с III стадией было

19,2±3,3%, в основной (1) группе – 20,0±4,6%, во второй 18,4±4,5%.

По характеристике лечебного воздействия при раке шейки матки были выделены 2 группы больных. В первую группу включено 20 пациентов с Ib2 и IIa2 стадией, которым проведен метронульный курс полихимиотерапии по схеме: цисплатин 60 мг/м² 1 день + иринотекан 60 мг/м² в 1, 8, 15 дни, в последующем выполнено оперативное вмешательство. Всем больным назначалась стандартная антиэметическая терапия, включающая в себя премедикацию кортикостероидами и блокаторами H2 гистаминовых рецепторов в процессе инфузии и в течение 3 последующих дней.

Оценка лечебного эффекта основывалась на анализе истории болезни, физикальных методов обследования, УЗИ органов малого таза. Общий анализ крови выполнялся трижды в течение цикла химиотерапии. Биохимические показатели и осмотр проводились перед и после проведения метронульного курса. Оценка терапевтического эффекта проводилась после курса полихимиотерапии. Лечение проводилось при количестве нейтрофилов более 1,5 на 10⁹ и количестве тромбоцитов более 100 тыс. в мл. Снижение доз предусматривалось при стойкой нейтропении не поддающейся коррекции.

По характеристике лечебного воздействия при раке тела матки выделены следующие 2 группы больных: в первую группу включено 35 больных умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, которым проведены неoadъювантные курсы полихимиотерапии по схеме: цисплатин 50 мг/м² + 5фторурацил 500-700 мг/м² + циклофосфан 500 мг/м², в последующем выполнено оперативное вмешательство. В послеоперационном периоде проведена дистанционная лучевая терапия. Во вторую группу вошли 38 больных с умеренно- и низкодифференцированной формой I-III стадии рака эндометрия, получившие комбинированное лечение в объеме хирургического лечения и послеоперационного курса дистанционной лучевой терапии. Выбор объема хирургического лечения соответствовал стандартам оперативного лечения. Основным объемом операции являлась радикальная гистерэктомия второго типа. В случае поражения придатков основной объем дополнялся оментэктомией.

Общее состояние было удовлетворительным у большинства пациентов и равнялось 0-1 по шкале ECOG.

Весь материал был внесен в компьютерную базу данных. Статистическая обработка материала проводилась методом общей и корреляционной статистики с использованием компьютерного статистического пакета программы SPSS for Windows (версия 15.0).

Результаты исследований.

Для оценки непосредственной эффективности проведенной полихимиотерапии выделяются три градации степени регрессии опухоли после проведения химиотерапии, при которых регрессия опухоли соответствовала от 100% до 75%, 75-50% и менее 50%. Эффективным ответом на цитостатическое воздействие считается резорбция опухоли в пределах от 100% до 50%.

Непосредственные результаты лечения рака шейки матки (РШМ). В результате проведения полихимиотерапии (ПХТ) в метронульном режиме по данным ультразвукового исследования общий положительный эффект от проведенного лечения (100-50%) наблюдался у 95,0% больных, из них эффективность 100-75% отмечена у 35,0%. У

5,0% больных ответ на проведенную химиотерапию был слабым.

Из представленных данных в таблице 1 можно видеть, что у большинства женщин эффективность химиотерапии была выше 50%.

Таблица 1 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком шейки матки в зависимости от стадии процесса

Стадия n=20	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Ib2 стадия	4 30,8±4,2	8 61,5±4,7	1 7,7±2,4
IIa2 стадия	3 42,9±5,9	4 57,1±4,6	0
Всего	7 35,0±6,4	12 60,0±5,6	1 5,0±2,3

* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05

Согласно приведенным данным, степень регрессии опухолей достигала значений от 100 до 75% и от 75 до 50% у большинства пролеченных больных РШМ, что свидетельствует об эффективности проводимого предоперационного курса ПХТ.

Непосредственные результаты от проведения ПХТ в зависимости от гистологических форм приведены в таблице 2. Регрессия опухоли отмечена у больных с плоскоклеточной неороговевающей карциномой у 25,0±4,7% наблюдалась регрессия 100-75%, у 75,0±6,4% больных – эффективность 75-50%. У больных с плоскоклеточной ороговевающей карциномой степень регрессии 100% - 75% достигнута у 57,1±5,9% больных регрессия на 75% - 50% достигнута у 42,9±8,4% больных. У пациентки с мезонефرويدной аденокарциномой степень регрессии была ниже 50%.

Таблица 2 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком шейки матки в зависимости от гистологической формы опухоли

Гистологическая форма	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Плоскоклеточный неороговевающий (n=12)	3 25,0±4,7	9 75,0±6,4*	-
Плоскоклеточный ороговевающий (n=7)	4 57,1±5,9*	3 42,9±8,4	-
Мезонефرويدная аденокарцинома (n=1)	-	-	1 100,0
Всего (n=20)	7 35,0±6,4	12 60,0±5,6	1 5,0±2,3

* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05

Ультразвуковые исследования проводили до и после метронульного курса ПХТ. Средний объем опухоли эндометрия до лечения у больных раком шейки матки Ib2 стадии составил 91,27±16,84см³. В процессе лечения отмечается уменьшение объема опухоли до 42,71±7,82см³. Индекс эффективности составил 2,1.

Динамика регрессии опухоли в зависимости от стадии процесса представлена в таблице 3. Более выраженный ответ на проведение химиотерапии наблюдался при IIa2 стадии (коэффициент эффективности – 3,6). В этой группе больных средний объем опухоли до лечения составил 92,75±17,67см³, после проведения ПХТ объем уменьшился до 25,68±4,72см³.

Таблица 3 – Динамика регрессии опухоли шейки матки в зависимости от стадии процесса

Стадии процесса (n=20)	Объем опухоли в см ³		Индекс эффективности
	До лечения	После ПХТ	
Ib2 стадия	91,27±16,84	42,71±7,82	2,1
Ila2 стадия	92,75±17,67	25,68±4,72*	3,6

* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения $p < 0,05$

В процессе химиотерапии были отмечены токсические побочные эффекты – гематологические и негематологические. Наиболее частым проявлением гематологической токсичности была лейкопения. Фебрильной нейтропении не было отмечено ни у одной больной. Негематологические осложнения в виде тошноты и рвоты были не выраженными. Алоpecia наблюдалась в 100% случаев. Смертей, связанных с токсичностью химиотерапии не было (таблица 4).

Таблица 4 – Гематологическая и негематологическая токсичность химиотерапии

Проявления токсичности	Степень				
	1	2	3	4	Всего
Анемия	5 (25%)	-	-	-	5 (25%)
Лейкопения	7 (35%)	1 (5%)	-	-	8 (40%)
Нейтропения	-	-	-	-	-
Тромбоцитопения	-	-	-	-	-
Алоpecia	-	-	-	-	20 (100%)
Тошнота/рвота	-	2 (10%)	-	-	2 (10%)
Диарея	3 (15%)	-	-	-	3 (15%)
Фебрильная нейтропения	-	-	-	-	-

Результаты применения метрономной полихимиотерапии, показали значительную эффективность у ранее не леченых больных – 95% (частичная регрессия+стабилизация процесса). В целом лечение удовлетворительно переносится, случаев отмены препаратов, либо прекращения лечения ввиду выраженной токсичности отмечено не было ни в одном из случаев.

У пациенток, получавших химиотерапию, не было отмечено существенных изменений в гематологических показателях, не было отмечено ни одного случая отмены препарата, либо прекращения лечения ввиду прогрессирования.

Всем пациенткам после метрономного курса ПХТ после нормализации клинико-лабораторных показателей произведено оперативное вмешательство. Оперативное лечение проводилось в объеме: Лапаротомия. Радикальная гистерэктомия III типа.

Пациентки вне зависимости от проведенной предоперационной терапии, были разделены на 2 группы. В первой группе, пациентки оперированы в обычном объеме: Лапаротомия. Радикальная гистерэктомия III типа. Во второй группе, пациенткам произведена нервосберегающая радикальная гистерэктомия III типа.

Из 50 пациенток, нервосберегающие операции проведены 14 (28%) пациенткам. Функция мочевого пузыря у данных пациенток восстанавливалась в среднем на 12-14 послеоперационные сутки (таблица 5).

Таблица 5 – Восстановление функции мочевого пузыря после нервосберегающих операций.

Таблица 6 – Характеристика операций. Интра- и послеоперационные осложнения

Осложнения	Количество, %	
	Нервосберегающая РГ (n=14)	Радикальная гистерэктомия (n=36)
Кровотечение	-	-
Мочеточниково-влагалищный свищ	-	1 (2,8%)
Нагноение послеоперационной раны	-	-
Дисфункция мочевого пузыря	1 (7,1%)	15 (41,7%)
Атония мочевого пузыря	-	1 (2,8%)
Полная эвентерация	-	-
Смерть	-	-
Характеристика оперативных вмешательств	Количество	
	Нервосберегающая РГ (n=14)	Радикальная гистерэктомия (n=36)
Продолжительность	198±22,6 мин.	161±19,8 мин.
Объем кровопотери	560±70,5 мл.	430±65,5

Таблица 6а

Функции органов	Нервосберегающая радикальная гистерэктомия III типа	Радикальная гистерэктомия III типа
Восстановление функции мочевого пузыря	12,6±3,4 сутки	23,4±4,5 сутки

Как видно из таблицы, восстановление функции мочевого пузыря, после нервосберегающих операций происходило в среднем на 11±4,7 суток раньше.

Характеристика оперативных вмешательств и осложнений интра-, послеоперационных представлена в таблице 6.

Продолжительность нервосберегающих операций была в среднем чуть больше 3 часов, когда средняя продолжительность операций без выделения нервных пучков на 30 минут менее продолжительна. Объем кровопотери при радикальной гистерэктомии около 400,0 мл. Незначительно больше кровопотеря при нервосберегающих радикальных гистерэктомиях. Однако достоверной разницы не выявлено. Анализ послеоперационных осложнений показал, что после радикальной гистерэктомии III типа в большинстве случаев встречалась дисфункция мочевого пузыря у 15 (41,7%) пациенток и атония мочевого пузыря у одной больной, что составило 2,8%. В течение послеоперационного периода данное осложнение было купировано у всех больных. Одна (2,8%) пациентка выписана с осложнением мочеточниково-влагалищный свищ. Через 2 месяца проведена операция по устранению свища.

Одной из задач исследования было изучить влияние коротких курсов ПХТ на инвазию опухоли в лимфоваскулярное пространство и метастазы в регионарных лимфатических узлах.

Таким образом, хирургическое лечение проведено всем 50 больным. Морфологическая характеристика послеоперационного материала представлена в таблице 7. Как видно из таблицы, в группе больных получавших ПХТ в метрономном режиме, опухолевые эмболы в сосудах и/или лимфатических щелях выявлены у 3 (15%)

пациенток, против 9 (30,0%) в группе с хирургическим лечением на I этапе. Сложно говорить о прямом влиянии химиотерапии на данный факт ввиду малочисленности исследуемого материала. Метастазы в лимфатические узлы обнаружены у 4 (20%) пациенток I группы, у больных, не получавших полихимиотерапию опухолевые клетки в тазовых лимфоузлах выявлены в 8 (26,7%) случаях.

Анализом данных морфологического исследования установлено, что метастазирование в лимфоваскулярное пространство больше в 2 раза в группе больных, которым не проводилась химиотерапия. И на 6,7 % больше обнаружено метастазов в тазовых лимфатических узлах.

По результатам гистологического исследования ориентировались в плане проведения послеоперационного лечения. У 13 (26%) больных выявлены метастазы в лимфоваскулярное пространство и тазовые лимфатические узлы. Данным больным назначена послеоперационная лучевая и химиолучевая терапия.

Таблица 7 – Морфологическая характеристика опухоли

		Количество случаев абс., %	
		I группа	II группа
Гистологическая структура	Плоскоклеточный неороговевающий рак	12 (60,0±7,5)	17 (56,7±7,6)
	Плоскоклеточный ороговевающий рак	7 (35,0±5,5)	13 (43,3±6,3)
	Мезонефرويدная аденокарцинома	1(5,0±1,7)	0
Глубина инвазии	нет инвазии	0	0
	до 0,5см	2 (10,0±3,2)	3 (10,0±3,4)
	до 1 см	8 (40,0±5,7)	11 (36,7±6,1)
	более 1 см	10 (50,0±6,2)	16 (53,3±7,5)
Инвазия в цервикальный канал	нет инвазии	13 (65,0±7,6)	11 (36,7±6,1)
	есть инвазия	7 (35,0±5,5)	19 (63,3±8,1)
Опухолевые эмболы в сосудах или лимфатич. щелях	нет	17 (85,0±8,5)	21 (70,0±8,3)
	есть	3 (15,0±3,5)*	9 (30,0±5,8)
Метастазы в лимфоузлы	нет метастазов	16 (8,0±8,2)	22 (73,3±8,5)
	есть метастазы	4 (20,0±4,2)	8 (26,7±5,6)
Край резекции влагалища	нет опухолевых клеток	19 (95,0±8,8)	29 (96,7±9,5)
	есть опухолевые клетки	1 (5,0±1,7)	1 (3,3±1,8)
Кардинальные и кресцово-маточные связи	нет опухолевых клеток	17 (85,0±8,5)	27 (90,0±9,1)
	есть опухолевые клетки	3 (15,0±3,5)	3 (10,0±3,4)
* - достоверность показателей метастазирования в лимфоваскулярное пространство в сравнении со II группой p<0,05			

Непосредственные результаты лечения рака тела матки (РТМ).

В результате проведения неоадьювантной полихимиотерапии по данным ультразвукового исследования общий положительный эффект от

проведенного лечения (100-50%) наблюдался у 74,3% больных РТМ, из них эффективность 100-75% отмечена у 45,7%. У 25,7% больных ответ на проведенную химиотерапию был слабым.

Из представленных данных в таблице 8 следует, что при I стадии заболевания число случаев при всех степенях эффективности было одинаковым по 33,3%. Общий положительный эффект наблюдался у 66,6% больных РТМ.

Таблица 8 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком тела матки в зависимости от стадии процесса

Стадия n=35	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
I стадия	<u>7</u> 33,3±8,0	<u>7</u> 33,3±8,0	<u>7</u> 33,3±8,0
II стадия	<u>5</u> 71,4±5,9 *	<u>1</u> 14,3±7,6	<u>1</u> 14,3±7,6
III стадия	<u>4</u> 57,1±5,9	<u>2</u> 28,6±7,6	<u>1</u> 14,3±8,4
Всего	16 45,7±8,4	10 28,6±7,6	9 25,7±7,4
* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05			

У больных с II стадией злокачественного процесса показатель общей эффективности составил 85,7%. Степень регрессии опухоли в пределах от 100 до 75% отмечена в 71,4±5,9% (p<0,05), от 75 до 50% и менее 50% в одинаковом числе случаев (14,3±7,6%).

Среди больных III стадией рака тела матки непосредственный эффект наблюдался также у 85,7% больных, однако отмечены различия в достижении процента регрессии опухолевого процесса, так частота полных регрессий процесса была несколько ниже - в 57,1%, что связано со степенью распространенности опухоли. Степень регрессии опухоли в пределах от 75 до 50% установлена в 28,6% случаев соответственно, менее 50% - у одной больной.

Согласно приведенным данным, степень регрессии опухолей II и III стадии достигала значений от 100 до 75% и от 75 до 50% у большинства пролеченных больных РТМ, что свидетельствует об эффективности проводимых предоперационных курсов ПХТ.

В таблице 9 приведены показатели непосредственных результатов ПХТ у больных раком тела матки в зависимости от возрастного периода. В группе больных репродуктивного возраста было одинаковое число случаев (50,0±8,2%) ответивших на химиотерапию и не давших ответа на нее, при этом регрессия опухоли отмечена от 75 до 50%. В группе пременопаузальных больных регрессия опухоли от 100 до 75% зарегистрирована в 45,5±8,4%, от 75 до 50% - в 36,3±8,1% случаев. И только у двух женщин опухоль уменьшилась менее чем на 50%. У женщин в менопаузе этот показатель оказался несколько выше 50,0% и 22,7% при регрессии 100-75% и 75-50% соответственно. Как видно, больших различий в степени регрессии опухоли под влиянием ПХТ во 2-ой и 3-ей возрастных группах не наблюдалось.

Таблица 9 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком тела матки в зависимости от возрастного периода

Возрастные группы (n=35)	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Репродуктивный	-	<u>1</u> 50,0±8,5 *	<u>1</u> 50,0±8,5 *

Таблица 10 – Непосредственные результаты ПХТ больных раком тела матки в зависимости от гистологической формы опухоли

Гистологическая форма	Степени регрессии опухоли (%) абс. / (M±m)%		
	100-75%	75-50%	< 50%
Умереннодифференцированная аденокарцинома (n=24)	<u>15</u> 62,5±5,7	<u>4</u> 16,7±4,4	<u>5</u> 20,8±4,8
Низкодифференцированная аденокарцинома (n=7)	<u>1</u> 14,2±5,9 **	<u>3</u> 42,9±8,4	<u>3</u> 42,9±8,4
Другие формы (n=4)	-	<u>3</u> 75,0±7,3 *	<u>1</u> 25,0±7,3 *
Всего (n=35)	<u>16</u> 45,7±8,4	<u>10</u> 28,6±7,6	<u>9</u> 25,7±7,4
* - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05			
** - достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,01			

Пременопаузальный	<u>5</u> 45,5±8,4	<u>4</u> 36,3±8,1	<u>2</u> 18,2±6,5
Менопаузальный	<u>11</u> 50,0±8,5	<u>5</u> 22,7±7,1	<u>6</u> 27,3±7,5
Всего (n=35)	<u>16</u> 45,7±8,4	<u>10</u> 28,6±7,6	<u>9</u> 25,7±7,4
- достоверность показателей регрессии опухоли в сравнении с общим числом p<0,05			

Непосредственные результаты от проведения ПХТ в зависимости от гистологических форм приведены в таблице 10. Регрессия опухоли отмечена у больных с умереннодифференцированными формами у 62,5±5,7% наблюдалась регрессия 100-75%, у 16,7±4,4% больных – эффективность 75-50%, и степень регрессии опухоли менее 50% зарегистрирована у 20,8±4,8%. У больных с низкодифференцированной аденокарциномой степень регрессии 100% - 75% достигнута у 14,3±5,9% больных регрессия на 75% - 50% достигнута у 42,9±8,4% больных.

Ультразвуковые исследования проводили в процессе комплексного лечения рака эндометрия для контроля динамики объема опухоли под влиянием ПХТ. Средний объем опухоли эндометрия до лечения у больных раком тела матки основной группы составил 5,7±1,7см³. В процессе лечения отмечается уменьшение объема опухоли до 3,9±1,8см³ после 1 курса полихимиотерапии и 2,8±1,9см³ после 2 курса.

Динамика регрессии опухоли в зависимости от стадии процесса представлена в таблице 11.

В группе больных I стадии рака тела матки средний объем опухоли до лечения составил 5,2±2,5см³, после проведения двух курсов ПХТ объем уменьшился до 2,7±1,7см³. Индекс эффективности составил после 1го курса 1,4 и после 2 курса 1,9.

Более выраженный ответ на проведение химиотерапии наблюдался при II и III стадиях (коэффициент эффективности после первого курса - 1,5). Причем, при II стадии эффект был выше. Объем опухоли до лечения при II и III стадиях составил 6,6±3,9см³ и 7,4±1,7см³; после 2 курса ПХТ объемы достигли 2,9±0,8см³ и 3,7±0,9см³ соответственно (p<0,05). Коэффициент эффективности после 2го курса химиотерапии при II стадии – 2,3, тогда как при III стадии 2,0.

Таблица 11 – Динамика регрессии опухоли в полости матки в зависимости от стадии процесса

Стадии процесса (n=35)	Объем опухоли в см ³			Индекс эффективности	
	До лечения	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ
I стадия	5,2±2,5	3,7±2,1	2,7±1,7	1,4	1,9
II стадия	6,6±3,9	4,4±1,1	2,9±0,8*	1,5	2,3
III стадия	7,4±1,7	4,9±1,3	3,7±0,9*	1,5	2,0
* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения p<0,05					

Эффективность применения ПХТ была проанализирована у больных раком тела матки в различных возрастных группах (таблица 12). Объем опухоли до лечения у больных репродуктивного возраста составил 7,5±2,8см³, у пременопаузальных больных – 4,8±1,1см³, у больных в менопаузе – 5,9±1,2см³.

Таблица 12 – Динамика регрессии опухоли в полости матки у больных раком тела матки в различные возрастные периоды

Возрастные группы (n=35)	Объем опухоли в см ³			Коэффициент эффективности	
	До лечения	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ
Репродуктивный	7,5±2,8	4,7±1,7	3,8±1,5	1,6	2,0
Пременопаузальный	4,8±1,1	3,4±0,9	2,3±0,8*	1,4	2,1
Менопаузальный	5,9±1,2	4,1±1,4	3,0±0,9*	1,4	2,0
* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения p<0,05					

Во всех возрастных группах после проведения 1 курса ПХТ отмечена тенденция к уменьшению объема опухоли (p<0,05), тогда как после 2 курса наблюдалась достоверная разница между величиной опухоли до и после лечения (p<0,01 и p<0,05). Индекс эффективности в этих группах от 2,0 до 2,5.

Во II возрастной группе уже после 1 курса ПХТ зарегистрировано значительное уменьшение опухолей от 6,8±1,4см³ до 4,4±0,9 см³ (p<0,05), и к моменту оперативного лечения этот показатель был равен 2,7±0,8см³ (p<0,01). Проведенный анализ показывает, что возраст больных не оказывает особого влияния на уменьшение размеров опухоли в процессе ПХТ.

Прослежена динамика изменений объема опухоли при различных гистологических вариантах (таблица 13). Наибольший объем опухоли до лечения (10,8%) наблюдался при опухолях железисто-плоскоклеточной и светлоклеточной формы, которые были объединены в группу других форм опухоли. У этих больных РТМ отмечался наиболее выраженный эффект от проведения химиотерапии, коэффициент составил 2,3, однако разница в показателях была недостоверной.

Таблица 13 – Динамика регрессии опухоли в полости матки в зависимости от гистологической формы

Гистологическая форма (n=35)	Объем опухоли в см ³			Индекс эффект-сти	
	До лечен.	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ	После 1 ПХТ	После 2 ПХТ
Умереннодифференцированная аденокарцинома	5,2±1,3	3,4±1,2	2,5±1,0	1,6	2,1
Низкодифференцированная аденокарцинома	5,6±0,9	3,8±1,2	3,2±1,1*	1,5	1,8
Другие формы	10,8±3,6	7,8±2,5	4,6±2,1	1,4	2,3

* - достоверность показателей регрессии объема опухоли в сравнении с объемом до лечения p<0,05

Достоверные результаты уменьшения объема опухоли под воздействием цитостатических агентов получены при низкодифференцированных формах аденокарциномы эндометрия. В этой группе больных до лечения объем опухоли составил 5,6±0,9 см³, после проведения 2х курсов химиотерапии объем уменьшился до 3,2±1,1 см³ (p<0,05), коэффициент эффективности составил 1,8.

Таким образом, применение полихимиотерапии в неoadъювантном режиме при раке шейки и тела матки является одним из важных моментов в современном лечении этих больных, и позволили сделать следующие выводы:

- В группе больных получавших ПХТ в метронежном режиме, опухолевые эмболы в сосудах и/или лимфатических щелях выявлены у 15% пациенток, против 30,0% в группе с хирургическим лечением на I этапе. Сложно говорить о прямом влиянии химиотерапии на данный факт ввиду малочисленности исследуемого материала. Метастазы в лимфатические узлы обнаружены у 20% пациенток, в группе не получавших полихимиотерапию опухолевые клетки в тазовых лимфоузлах выявлены в 26,7% случаях.

- Применение метронежной полихимиотерапии показало значительную эффективность у ранее не леченых больных РШМ – 95% (частичная регрессия+стабилизация процесса). Лечение больными переносится удовлетворительно, случаев отмены препаратов, либо прекращения лечения ввиду выраженной токсичности отмечено не было ни в одном из случаев.

- Восстановление функции мочевого пузыря, после нервосберегающих операций происходит в среднем на 11±4,7 суток раньше, что существенно сказывается на качестве жизни пациенток с РШМ и имеет положительный экономический эффект.

- Сравнение хирургического лечения инвазивного РШМ при традиционной и нервосберегательной технике РГ показало, что нет достоверной разницы в продолжительности операции, объеме кровопотери. Выявлена положительная корреляционная зависимость между нервосберегающей операцией и сроками восстановления функции мочевого пузыря и отрицательная с развитием послеоперационных осложнений.

- Метод комплексной терапии с применением неoadъювантной полихимиотерапии по предложенной схеме у больных раком тела матки позволил получить:

а) терапевтический эффект в 74,3% случаев.

б) непосредственный эффект был выше у больных II стадией (степень регрессии более 75% установлена в 71,4±5,9% случаев).

в) оценка лекарственного патоморфоза установила II-III степени повреждения в 88,5% случаев (p<0,05).

- Непосредственные результаты больных РТМ показали, что наиболее выраженный эффект от химиотерапевтического лечения наблюдается при II и III стадиях злокачественного процесса не зависимо от возраста. При этом более выраженный эффект отмечается при II стадии заболевания.

- Имеется тенденция лучшего ответа на цитостатическое воздействие при низкодифференцированных аденокарциномах, железисто-плоскоклеточном и светлоклеточной формах эндометриоидной аденокарциномы.

Список литературы

1. Давыдов М.И., Аксель Е. М. Заболеваемость злокачественными новообразованиями населения России и стран СНГ в 2008 г. // Вестник РОНЦ им. Н.Н. Блохина. РАМН. - 2010. - С. 52-62.
2. Байназарова А. А. Внутриартериальная полихимиотерапия в комплексном лечении рака тела матки: автореф. ... докт. мед. наук. - Алматы, 2001. - 39 с.
3. Резцова В.В. Роль повреждений ДНК в регрессии опухолей после химиотерапии // Вопр. онкол. - 2007. - Т. 53, № 3. - С. 262-268.
4. Fleming G. Adjuvant Therapy for High-risk Adenocarcinoma of the Uterus // ASCO, 2008. - P 230-233.
5. Акимов А. А., Иванов С.Д., Хансон К.П. Апоптоз и лучевая терапия злокачественных новообразований // Вопр. онкол. - 2003. - Т. 49. - С. 261-9.

Summary

M.R.Kayrbaev, Zh.K. Chingissova, E.K. Kukubasov, R.Sh. Shalbaeva, Zh.A.Dossakhanov

The role of neoadjuvant chemotherapy in the treatment of gynecological cancer

Keywords: cervical cancer, uterine cancer, neoadjuvant chemotherapy

We have studied two groups of patients: the main group of 20 patients with cervical cancer underwent metronomic and the group of 35 patients with cancer of the uterine body underwent neoadjuvant chemotherapy. All patients underwent surgical treatment.

The use of metronomic chemotherapy showed significant efficiency of treatment of patients with cervical cancer- 95% (partial response and stabilization process.)

Bladder function after nerve-sparing surgery is restored in 11 ± 4.7 days earlier, which significantly affects the quality of life of patients with cervical cancer and has a positive economic effect.

Complex therapy with the use of neoadjuvant chemotherapy according to the proposed scheme for patients with cancer of the corpus uteri yielded: therapeutic effects in 73.4% of cases, the effect was greater with patients with stage I (the degree of regression of 75% was in 71.4 ± 5.9% cases), drug pathomorphosis II-III degree damage is set in 88 cases.

The results of application of chemotherapy in treatment of patients with cervical cancer and cancer of the uterine body prove the efficiency of treatment of these patients

Тұжырым

М.Р.Қайрбаев, Ж.К.Чингисова, Е.К.Кукубасов, Р.Ш.Шалбаева, Ж.Досаханов

Онкогинекологиялық қатерлі ісіктерін емдеудегі неoadъювантты полихимиотерапияның маңызы

Бұл жұмыста 2 топтағы науқастар зерттелді: жатыр мойны қатерлі ісігі сырқатымен ауырған негізгі топтағы 20 науқасқа полихимиотерапияның

(ПХТ) метрономды курсы және жатыр денесінің қатерлі ісігімен ауырған 35 науқасқа адъювантты емес полихимиотерапия курсы жүргізілді.

Метрономды полихимиотерапияны қолдану жатыр мойны қатерлі ісігі сырқатымен емделмеген науқастардың емдеу нәтижесінің 95% кетерілгені байқалды (жартылай регрессия + процесстің тұрақталуы). Нервкорғау операциясынан кейін қуық қызметінің орнына келуі орташа есеппен 11+4,7 тәулікке ерте болады, бұл жатыр мойны қатерлі ісігі сырқатымен ауырған науқастардың емір СҰРУ сапасына біршама әсер етеді және оң экономикалық нәтиже береді.

Жатыр қатерлі сырқатымен ауырған науқастарға ұсынылған кесте бойынша адъювантты емес ПХТ қолданылған комплексті емдеу - келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді: терапиялық әсер 74,3% жаздайда; тәжірибесі 2 сатылы науқастарда жазары

нәтиже берді (75%-дан жазары регрессия дәрежесі $71,4 \pm 5,9\%$ жаздайда анықталды); 88,5% жаздайда II-III дәрежедегі дерлік патоморфоз анықталды.

Жатыр денесінің қатерлі ісігімен және жатыр мойны қатерлі ісігімен ауыратын науқастарды адъювантты емес ПХТ қолдану арқылы алынған нәтижелер, осы науқастарға емнің тиімді екендігінің куәсі болады.

Түпінді сөздер жатыр мойнының қатерлі ісігі, жатыр денесінің қатерлі ісігі, неоадъювантты полихимиотерапия.

M.R.Kayrbaev, Zh.K. Chingissova, E.K. Kukubasov, R.Sh. Shalbaeva, Zh.A.Dossakhanov

The role of neoadjuvant chemotherapy in the treatment of gynecological cancer

Keywords: cervical cancer; uterine cancer; neoadjuvant chemotherapy